

Absceso periamigdalino y retrofaríngeo

1) Introducción y relevancia clínica

Los **abscesos profundos del cuello** representan infecciones supuradas en espacios cervicofaciales que, por su vecindad con la vía aérea y estructuras neurovasculares, pueden evolucionar a **compromiso respiratorio, mediastinitis y sepsis**. Dentro de ellos, dos entidades destacan en la práctica diaria:

- **Absceso periamigdalino (APA)**: colección purulenta entre la cápsula de la amígdala palatina y el músculo constrictor superior. Es el **absceso profundo de cuello más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes**, típicamente como complicación de una **faringoamigdalitis aguda**.
- **Absceso retrofaríngeo (ARF)**: colección en el **espacio retrofaríngeo** (entre la fascia bucofaríngea y la fascia prevertebral), más frecuente en **niños pequeños (2–4 años)** por linfadenitis supurativa de ganglios retrofaríngeos o por traumatismos de orofaringe.

Relevancia clínica: ambos pueden comprometer la **vía aérea**, requerir drenaje urgente y antibioterapia EV. Su reconocimiento rápido y derivación oportuna al nivel hospitalario resulta **crítico**. Son temas clásicos del **EUNACOM** por su semiología sugerente y decisiones terapéuticas concretas.

2) Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Absceso periamigdalino

- **Secuencia típica**: faringoamigdalitis (viral o por *Streptococcus pyogenes*) → **celulitis periamigdalina** → **coalescencia y colección purulenta** entre cápsula amigdalar y constrictor superior (lo más habitual es en el **polo superior**).
- **Microbiología**: infección **polimicrobiana**. Patógenos frecuentes: *S. pyogenes*, *Staphylococcus aureus* (incluido **SAMR** comunitario según epidemiología local), anaerobios orales (*Fusobacterium necrophorum*, *Prevotella*, *Peptostreptococcus*) y bacilos Gram negativos orales.
- **Factores de riesgo**: amigdalitis a repetición, tabaquismo, mala higiene oral, inmunodeficiencias, retraso o falla en el tratamiento antibiótico de amigdalitis.

2.2. Absceso retrofaríngeo

- **Origen:** en niños, por propagación desde **ganglios linfáticos retrofaríngeos** tras infecciones de vía aérea alta; en adolescentes/adultos, más frecuente por **trauma** (espinas de pescado, cuerpos extraños, instrumentación) o extensión desde otros espacios.
 - **Microbiología:** flora orofaríngea mixta; *S. pyogenes*, *S. aureus* (considerar SAMR), anaerobios y bacilos Gram negativos; en traumatismos, flora mixta incluyendo bacterias ambientales.
 - **Vía de diseminación:** el **espacio retrofaríngeo** se continúa caudalmente con el **espacio peligroso** hasta el mediastino → riesgo de **mediastinitis**.
-

3) Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Absceso periamigdalino (APA)

Síntomas cardinales:

- **Odinofagia severa unilateral** que progresa a **odinofagia intensa con trismus**.
- **Sialorrea y disfagia** (incluso a líquidos).
- **Voz “hot potato”** (voz gangosa, apagada).
- **Fiebre y malestar general**.
- **Halitosis**.

Signos característicos:

- **Trismus** (contractura pterigoidea por dolor).
- **Desviación de la úvula** hacia el lado sano.
- **Abombamiento del pilar anterior y polo superior amigdalario** del lado afectado.
- **Plenitud periamigdalina** y dolor a la palpación.
- **Adenopatías laterocervicales dolorosas ipsilaterales**.

Diagnóstico diferencial del cuadro “amigdalitis con trismus”:

- Celulitis periamigdalina (preabsceso).
- **Absceso parafaríngeo** (dolor cervical profundo, tortícolis).
- **Angina de Ludwig** (infección del piso de boca): elevación de lengua, induración submandibular, riesgo alto de asfixia.
- Neoplasias o masas periamigdalinas (menos probable en curso agudo).
- Faringitis severa por VEB (mononucleosis) con gran hipertrofia amigdalar (generalmente bilateral, sin desviación marcada de úvula ni trismus pronunciado).

3.2. Absceso retrofaríngeo (ARF)

Síntomas cardinales (niños):

- Fiebre alta, irritabilidad.
- Odinofagia, sialorrea, hiporexia.
- Tortícolis o rigidez cervical (el niño “no quiere mover el cuello”).
- Disnea estridorosa o ronquido nocturno (signo de alarma).
- Disfonía y voz apagada.

Examen físico:

- Abombamiento de pared faríngea posterior (no siempre evidente sin endoscopia).
- Dolor a la palpación cervical, limitación dolorosa de la extensión del cuello.
- En lactantes: cuadro séptico con rechazo alimentario y sialorrea.

Diagnóstico diferencial del “dolor faríngeo + rigidez cervical”:

- Meningitis (pero con signos meníngeos y alteraciones neurológicas).
- Amigdalitis severa sin colección retrofaríngea.
- Absceso parafaríngeo (dolor lateral y trismus).
- Linfadenitis cervical supurativa.
- Epiglotitis (estridor, sialorrea, posición de trípode; urgencia).

□ **Red flags (derivación urgente / riesgo de vía aérea):** estridor, dificultad respiratoria, trismus severo, incapacidad para manejar secreciones, voz apagada progresiva, dolor cervical con rigidez marcada, posición antálgica (olfateo).

4) Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Absceso periamigdalino

- **Diagnóstico principalmente clínico.** Si el cuadro es típico y hay recursos, se recomienda **punción-aspiración** con aguja para confirmar pus antes de la incisión.
- **Laboratorio:** hemograma (leucocitosis neutrofílica), PCR elevada; hemocultivos si aspecto séptico.
- **Imagen** (si duda diagnóstica, extensión atípica o mala respuesta inicial):
 - **Ecografía intraoral o cervical** (operador-dependiente, útil para diferenciar celulitis vs colección).
 - **TAC cuello con contraste** si sospecha compromiso parafaríngeo/retrofaríngeo o si la exploración es limitada por el trismus.

4.2. Absceso retrofaríngeo

- **Sospecha clínica + imagen:**
 - **TAC de cuello con contraste:** estudio de elección; delimita colección, extensión a espacios profundos, desplazamiento de la vía aérea y complicaciones (trombosis yugular interna, mediastinitis).
 - En niños estables, puede apoyarse con **radiografía lateral de cuello** (ensanchamiento del espacio retrofaríngeo), aunque es menos sensible.
- **Laboratorio:** hemograma, PCR, hemocultivos si febril alto/sepsis.
- **Microbiología:** cultivo del material purulento si se realiza drenaje.

Criterios clínicos de sospecha fuerte:

- APA: odinofagia severa unilateral + trismus + desviación de úvula.
- ARF (niño): fiebre + tortícolis + sialorrea ± estridor/ronquido + abombamiento retrofaríngeo.

5) Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo integra **aseguramiento de la vía aérea**, **antibioterapia empírica de amplio espectro**, **analgesia/antiinflamación**, **hidratación** y **drenaje** cuando corresponde. La **derivación hospitalaria** es la regla en cuadros moderados a severos o con criterios de alarma.

5.1. Medidas iniciales y soporte

- **Vía aérea primero:** sentar al paciente, oxígeno si hipoxemia, monitorización. En estridor, dificultad respiratoria o imposibilidad de manejar secreciones → **anestesia/ORL** para evaluación urgente; evitar agitación.
- **Hidratación EV** si disfagia significativa.
- **Analgésicos/antipiréticos:** paracetamol, AINEs; considerar **corticoide EV** (ej. dexametasona 4–8 mg en adultos; 0,15–0,6 mg/kg en niños) para disminuir edema y dolor (especialmente útil en ARF con compromiso de vía aérea o trismus importante).
- **Ayuno** si se prevé drenaje.

5.2. Antibióticos empíricos

Cobertura objetivo: *Streptococcus pyogenes*, *S. aureus* ($\pm$ SAMR comunitario según epidemiología), **anaerobios orales** y bacilos Gram negativos.

Esquemas frecuentes (adultos):

- **Ampicilina/sulbactam EV** 3 g c/6–8 h **o**
- **Ceftriaxona EV** 2 g/día + **metronidazol EV** 500 mg c/8 h.
- Sospecha/alta tasa de **SAMR**: añadir **vancomicina EV** (ajuste según peso y función renal) **o** linezolid.

Pediatría (dosis según peso):

- **Ampicilina/sulbactam EV** 100–200 mg/kg/día (ampicilina) divididos c/6 h **o**
- **Ceftriaxona EV** 50–75 mg/kg/día + **metronidazol EV** 30 mg/kg/día dividido c/8 h.
- Considerar **vancomicina** si riesgo SAMR.

Transición a VO una vez afebril, con buena respuesta clínica: amoxicilina/ác. clavulánico o clindamicina (alergia a penicilina), completando **10–14 días** totales (APA) o **14–21 días** (ARF o espacios profundos).

5.3. Drenaje y procedimientos

Absceso periamigdalino

- **Punción-aspiración** guiada por visión (y/o ecografía intraoral) en el punto de máxima fluctuación (generalmente superomedial).
- **Incisión y drenaje (I&D)** con bisturí protegido: opción preferida cuando hay colección evidente o recidiva; realizar con anestesia local o general (según cooperación/trismus).
- **Amigdalectomía de urgencia (“en caliente”)**: considerar en
 - Recurrencias,
 - Fallo de drenaje,
 - Absceso bilateral,
 - Pacientes con obstrucción significativa o sangrado.

Más frecuente es **amigdalectomía diferida** (semanas después) en casos de recurrencia.

Precaución: uso de separadores y aspiración adecuada; mantener el **eje de punción paralelo al plano de la amígdala** para evitar lesión de la **carótida interna** (posterolateral).

Absceso retrofaríngeo

- **ARF con compromiso de vía aérea o colección >2–2,5 cm: drenaje quirúrgico** (transoral o cervical externo) en pabellón con anestesia general, control de vía aérea por anestesia/ORL.
- **Colecciones pequeñas, sin compromiso respiratorio y buen estado general:** podrían manejarse con **antibioticoterapia EV y observación** estrecha 24–48 h; si no hay respuesta, proceder a drenaje.

6) Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones del APA

- **Obstrucción de vía aérea** por edema o extensión.
- **Absceso parafaríngeo** o **retrofaríngeo** por diseminación.
- **Sepsis**.
- **Síndrome de Lemierre** (*Fusobacterium necrophorum*): tromboflebitis séptica de vena yugular interna → **embolia séptica pulmonar** (fiebre persistente, odinofagia, dolor cervical; sospechar si evolución tórpida).
- **Hemorragia** (lesión vascular durante drenaje).
- **Recurrencia** (10–15%); mayor riesgo en fumadores y en amigdalitis recurrente previa.

6.2. Complicaciones del ARF

- **Compromiso respiratorio** (estridor, asfixia).
- **Mediastinitis descendente** por extensión al “espacio peligroso”.
- **Trombosis de vena yugular interna**.
- **Sepsis y shock séptico**.
- **Neumonía aspirativa**.
- **Osteomielitis vertebral/cervical** (raro).

6.3. Pronóstico

- Con manejo oportuno (vía aérea + antibiótico adecuado ± drenaje), el **pronóstico es excelente**.
- En ARF, el retraso diagnóstico aumenta **morbimortalidad** por complicaciones mediastinales; por ello, el **umbral para imagen y derivación debe ser bajo**.

7) Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **APA**: triada útil → **odinofagia intensa unilateral + trismus + desviación de úvula**.
2. **ARF pediátrico**: **fiebre + tortícolis + sialorrea** (con o sin estridor) = **imagen y derivación**.
3. La **TAC con contraste** define extensión y colecciones en espacios profundos (ARF, parafaríngeo).
4. **Cobertura anaerobia** siempre (metronidazol o β -lactámico con inhibidor) y considerar **SAMR** según epidemiología.
5. **Corticoide EV** puede mejorar dolor, trismus y edema de vía aérea en fase aguda.
6. **Drenaje** precoz si colección clara o falta de respuesta a antibióticos.
7. Tras APA, valorar **amigdalectomía diferida** en pacientes con amigdalitis recurrente.

Errores comunes

- Tratar APA como “amigdalitis común” sin evaluar trismus ni desviación de úvula.
- Retrasar **derivación** en niños con signos de **ARF**.
- Olvidar cubrir **anaerobios** o **SAMR** cuando corresponde.
- Drenar sin **asegurar vía aérea** en pacientes con compromiso respiratorio.
- Realizar punciones profundas en APA sin orientación anatómica (riesgo vascular).
- Suspender antibióticos demasiado pronto; no completar **10–14 días** (APA) o **14–21 días** (ARF/espacios profundos).

8) Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **APA**: complicación supurada de amigdalitis; clínica con **trismus, odinofagia intensa y desviación de úvula**.
2. **ARF**: más común en niños; **fiebre, tortícolis, sialorrea** y posible **estridor** → **TAC con contraste y derivación urgente**.
3. El manejo prioriza **vía aérea, antibiótico EV de amplio espectro** (estreptococo, anaerobios, $\pm$ SAMR) y **analgesia/corticoide**.

4. **Drenaje** (punción/I&D en APA; transoral o cervical en ARF) si hay colección, mala respuesta o compromiso de vía aérea.
5. Complicaciones graves: **mediastinitis, síndrome de Lemierre, sepsis y obstrucción de vía aérea.**
6. Tras control agudo, completar **10–14 días** (APA) o **14–21 días** (ARF) de antibiótico total; transición a VO al mejorar.
7. Considerar **amigdalectomía diferida** en APA recurrente o antecedentes de amigdalitis de repetición.